

39. SVILUPPO DELL'ANSA INTESTINALE

DURATA : 20:47

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce lo sviluppo embriologico dell'ansa intestinale, concentrandosi sulla rotazione antioraria dell'intestino, sull'importanza dell'arteria mesenterica superiore e sulla sua influenza sulla dinamica di crescita intestinale. I concetti chiave trattati includono la relazione tra stomaco, fegato e cuore, nonché i diversi punti di appoggio essenziali per lo sviluppo e il funzionamento dell'intestino. Inoltre, il video esplora i legami tra le emozioni e la salute intestinale, dettagliando come sentimenti come la rabbia o la paura possano influenzare la digestione. Imparerete anche l'importanza di considerare la dinamica peritoneale nel trattamento dei disturbi intestinali, arricchendo così il vostro approccio terapeutico in osteopatia.

SVILUPPO DELL'ANSA INTESTINALE

Il **cordone ombelicale** è inizialmente voluminoso, ma si ridurrà nel corso dello sviluppo. Inizialmente, l'**intestino** si sviluppa al di fuori della cavità peritoneale, a causa di un **apporto trofico** importante, fornito principalmente dall'**arteria mesenterica superiore**. Questa arteria, che si divide dall'aorta, costituisce l'asse della rotazione intestinale.

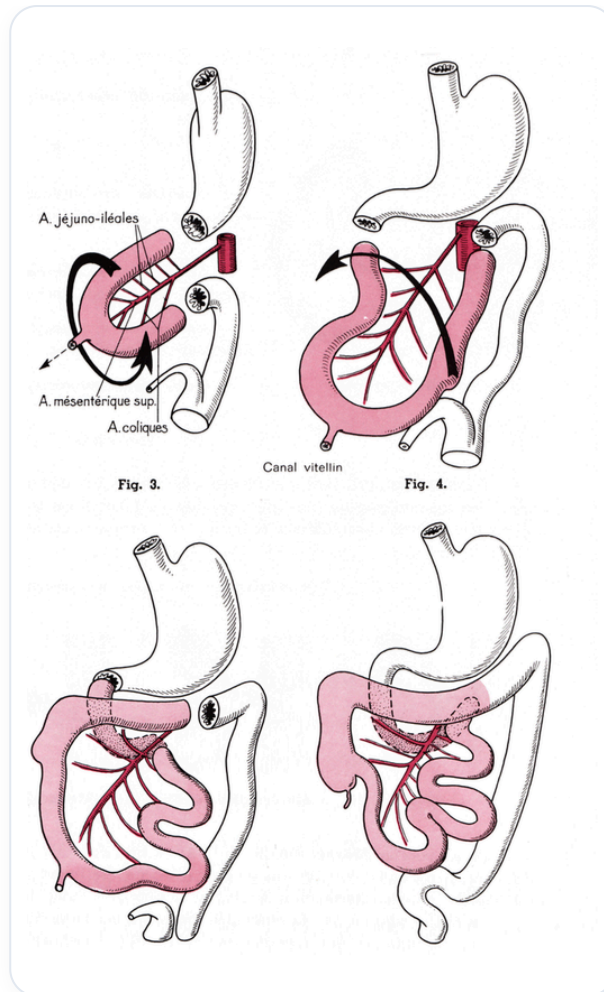


FIG. — Rotazione ansa intestinale

La rotazione dell'intestino avviene in senso **antiorario**, dall'avanti all'indietro. Parallelamente, si forma un **tubo epatogastrico** e un tubo digerente. Si osserva anche una struttura mesodermica, avvolta in un tessuto, corrispondente al **futuro compito** a livello ombelicale, il **canale onfalo-mesenterico**. I vasi sanguigni si sviluppano maggiormente in questa regione.

Si constata una **sincronicità** tra lo stomaco e la rotazione dell'intestino. Quando lo stomaco si posiziona verso sinistra, il fegato si sposta verso destra. Questo movimento comporta anche un posizionamento del cuore a sinistra, causando una congestione splenica. Il **colon** inizia a gonfiarsi, e l'arteria mesenterica superiore diventa il punto di appoggio fondamentale per lo sviluppo intestinale.

Sul piano vertebrale, l'arteria mesenterica superiore corrisponde all'asse di **D12-L1**, che è legato alle zone di inserzione dei pilastri diaframmatici. Questo punto di appoggio è essenziale per il corpo e influenza la dinamica di crescita dell'intestino.

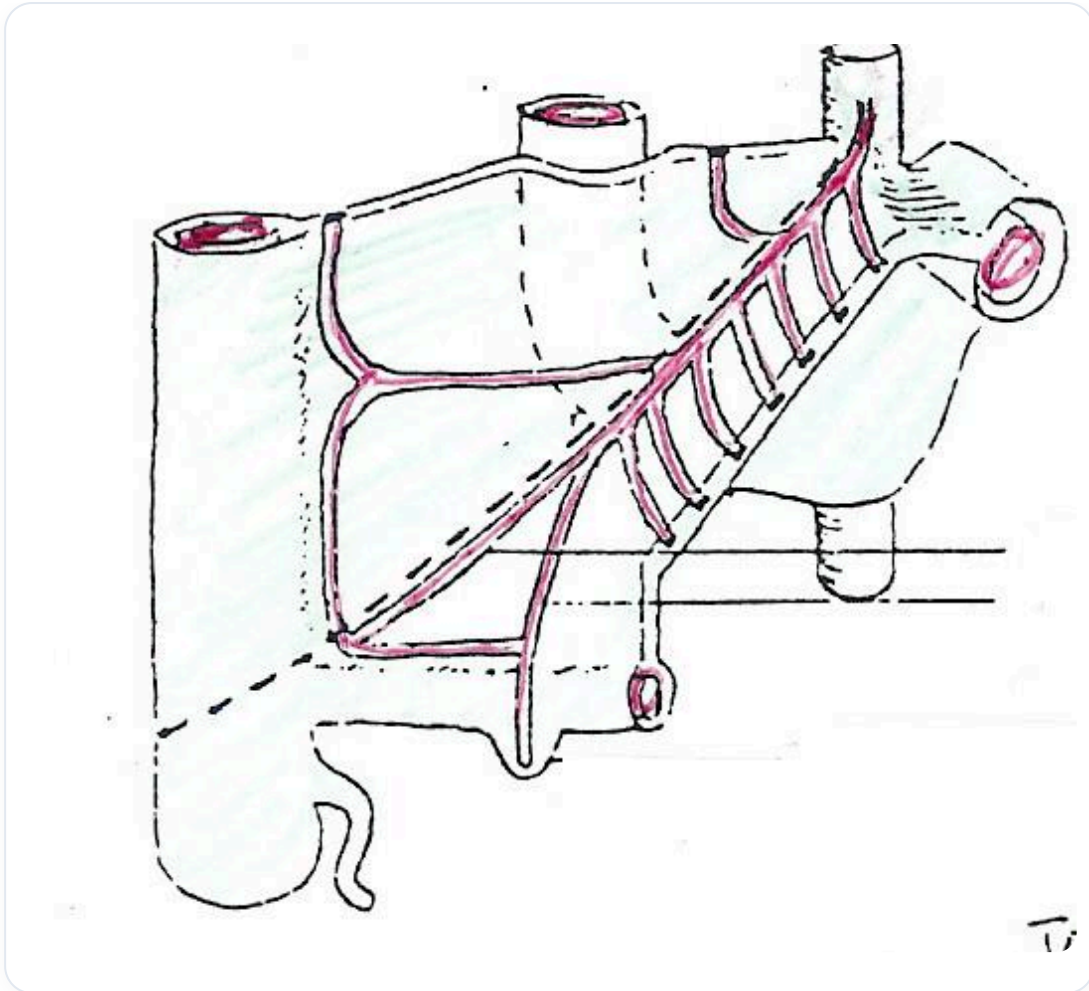


FIG. — Tronchi arteriosi embrionali

La crescita dell'intestino è caratterizzata da **velocità differenziali** legate a polarità. Una maggiore concentrazione metabolica si sviluppa verso l'alto, mentre la parte inferiore cresce meno rapidamente, formando così l'abbozzo dell'**angolo colico sinistro**. Questo movimento di crescita e rotazione è cruciale per la formazione dell'intestino.

Osservando la dinamica dell'intestino, si possono identificare diversi punti di appoggio importanti: l'arteria mesenterica, l'angolo colico sinistro e il quadro duodenale. Questi punti di appoggio sono essenziali per lo sviluppo e la funzione dell'intestino.

Il **canale onfalo-mesenterico**, che è l'asse di rotazione, termina con un residuo chiamato **diverticolo di Meckel**, situato tra l'asse pubico e il cieco. Lo sviluppo del cervello è anch'esso dipendente dal sistema vascolare digestivo. Se l'apporto trofico è insufficiente, ciò può causare complicazioni.

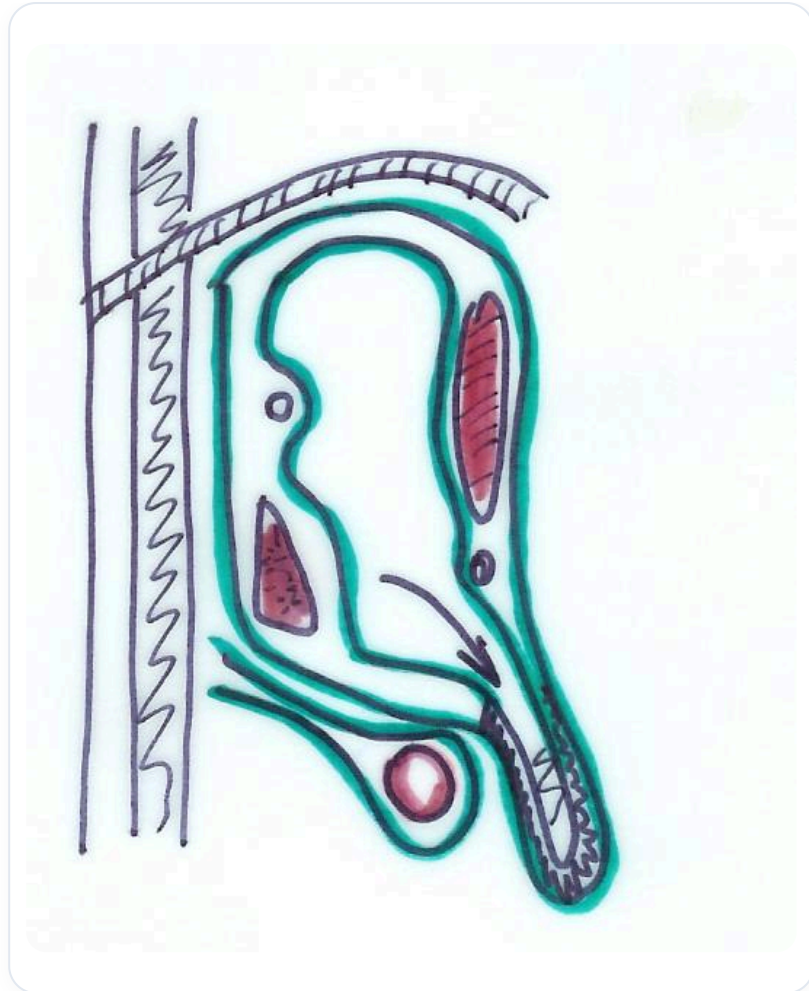


FIG. — Circolazione delle villosità intestinali

La reintegrazione dell'intestino avviene durante lo sviluppo, in particolare intorno al terzo mese di gravidanza, quando il cordone ombelicale inizia a formarsi. Questo processo è cruciale per stabilire le connessioni con la madre, in particolare attraverso la **cavità amniotica**, che permette scambi elettrolitici e ormonali.

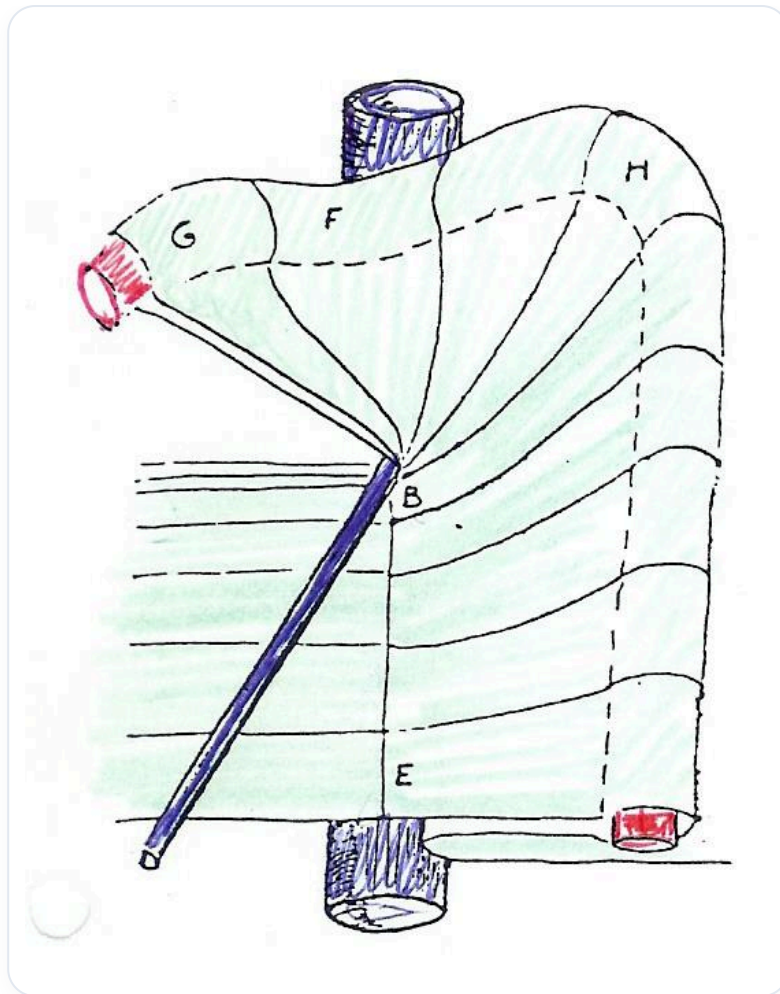


FIG. — Pieghe ventrali/laterali embrionali

Le emozioni e gli stati d'animo sono anch'essi legati alla salute intestinale. Il **colon ascendente** è associato alle ingiustizie alimentari, mentre il **colon trasverso** rappresenta gli umori dell'anima. Emozioni come la rabbia e la paura possono influenzare la salute digestiva.

Il **colon discendente** è legato a problematiche familiari e alla ricerca di indipendenza. L'**appendice** e il **cieco** giocano un ruolo importante nella difesa immunitaria. I problemi intestinali nei bambini, come le **appendiciti**, possono essere legati a fasi di sviluppo embrionale.

Il trattamento dei disturbi intestinali deve tenere conto della dinamica peritoneale e delle relazioni tra i diversi organi. La stabilizzazione del quadro peritoneale può aiutare a risolvere numerosi problemi di salute, incluse infezioni e infiammazioni.

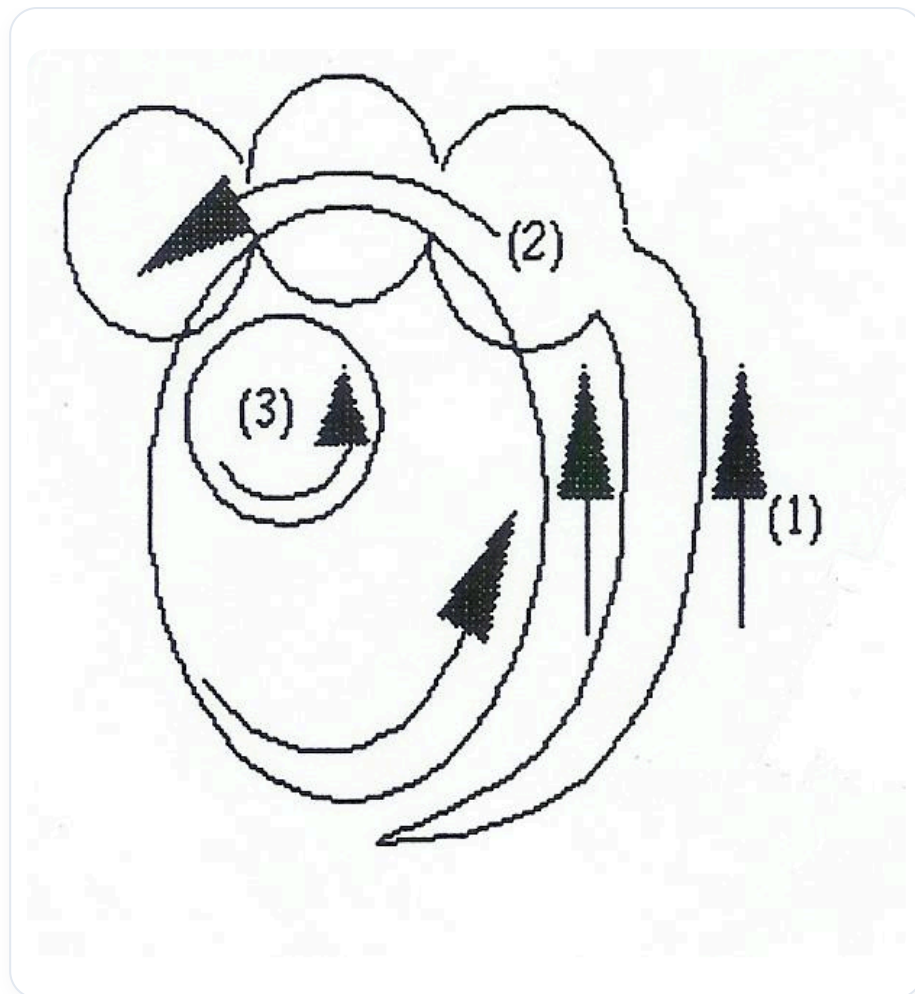


FIG. — Vortice embriologico

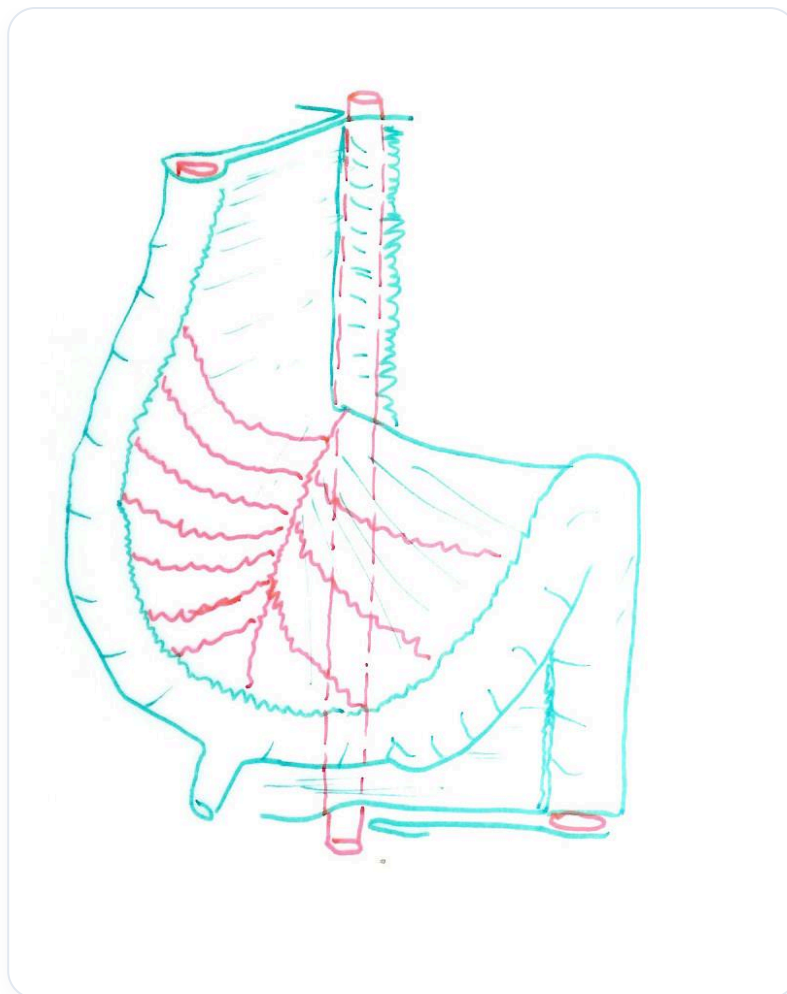


FIG. — Apparato digerente embrionale

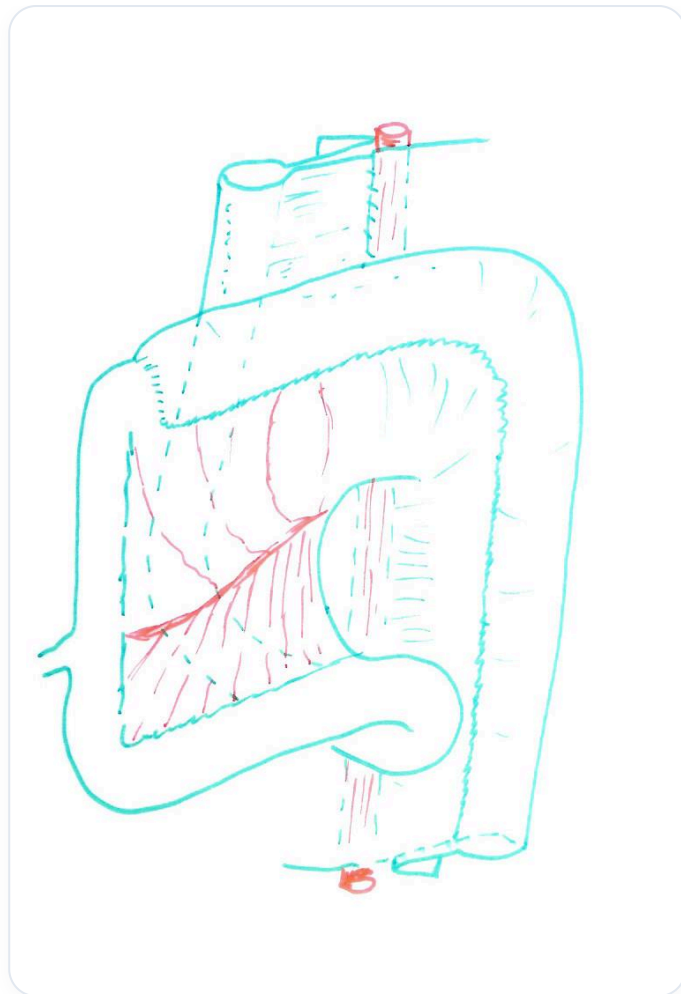


FIG. — Intestino medio, rotazione

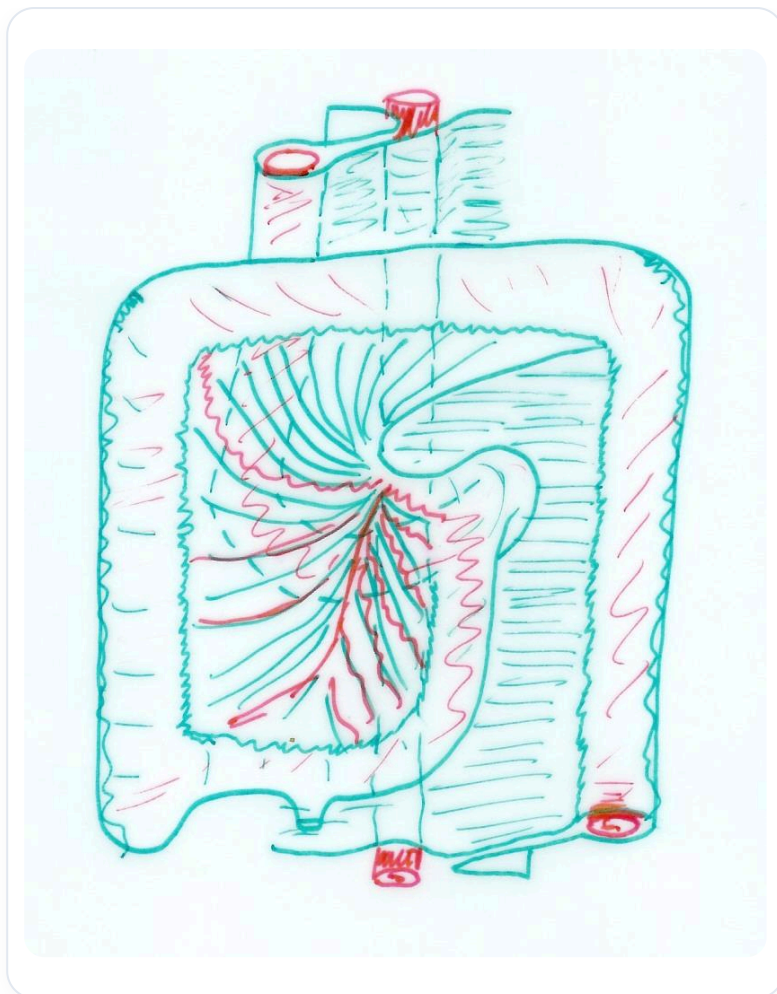


FIG. — Intestino tenue vascolarizzato

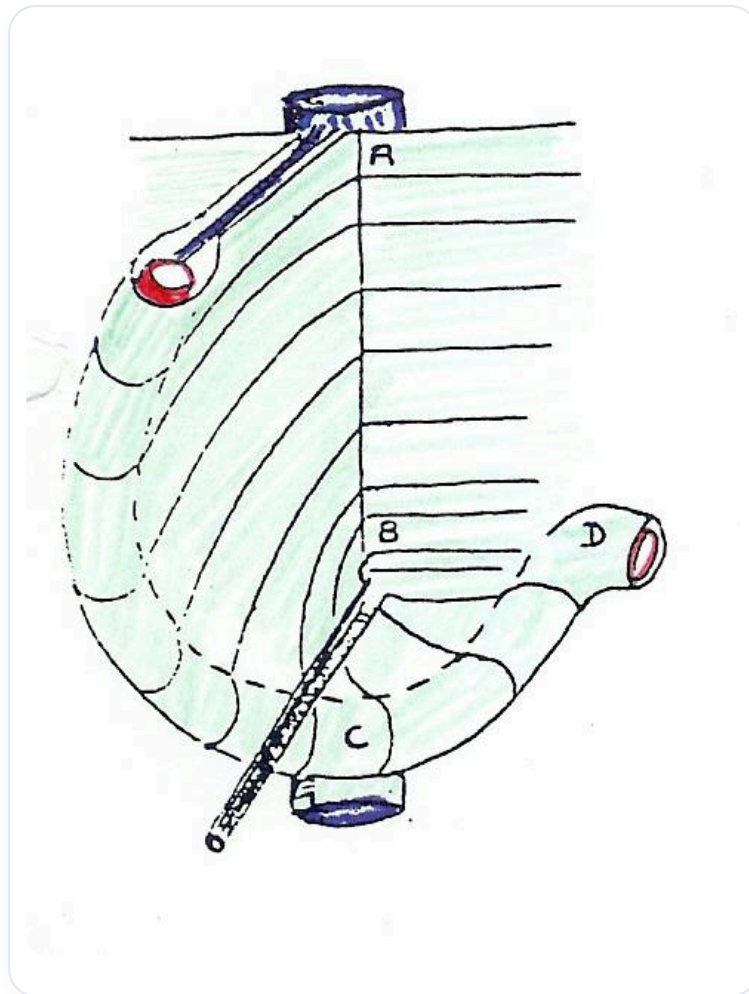


FIG. — Amniocentesi, Embrione, Utero

Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculieuse longitudinale fermée*.

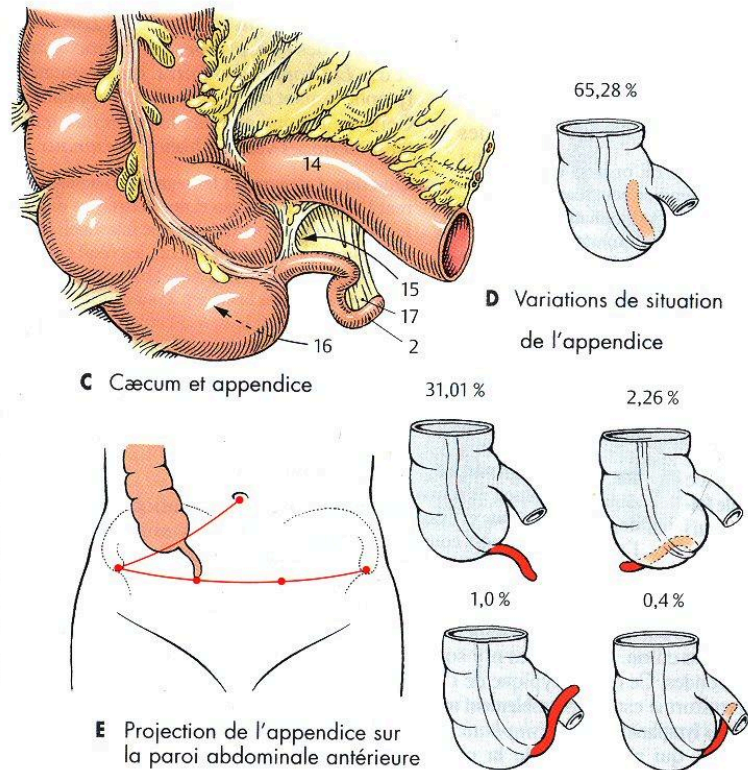


FIG. — Appendice, cieco, variazioni

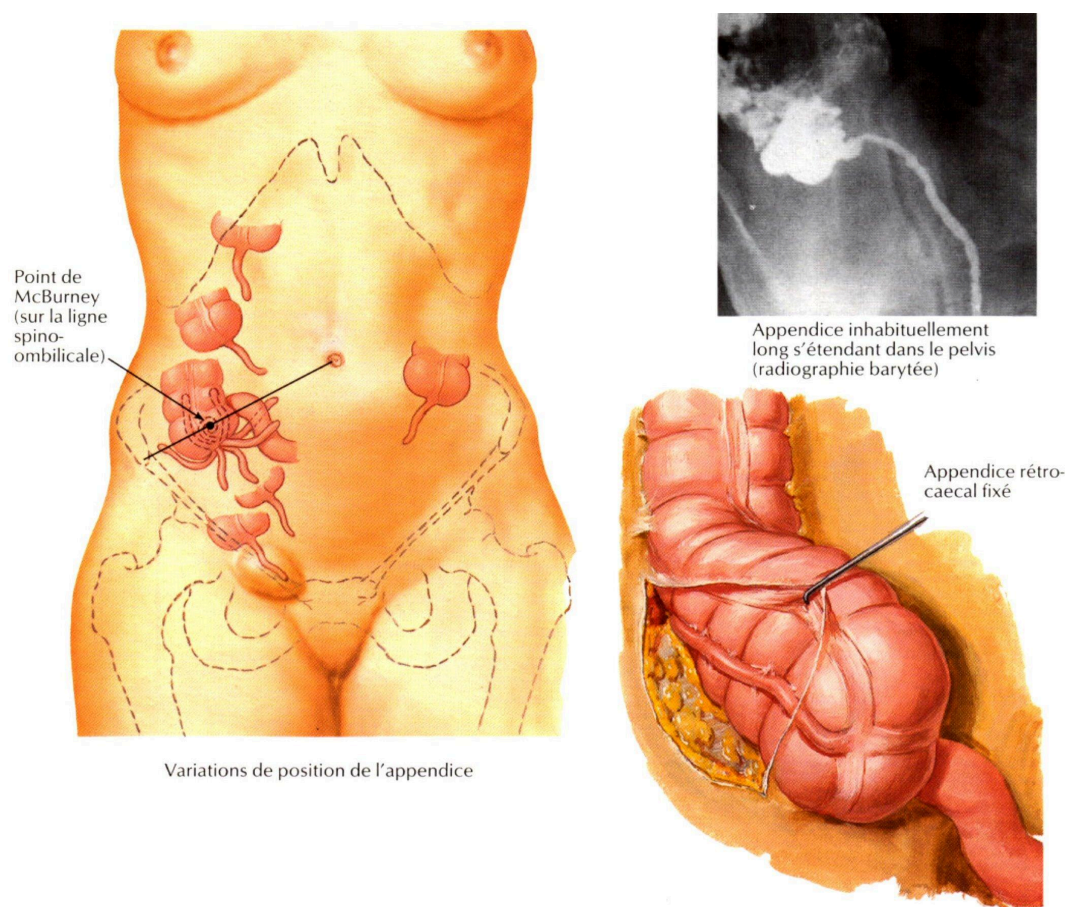


FIG. — Posizione dell'appendice

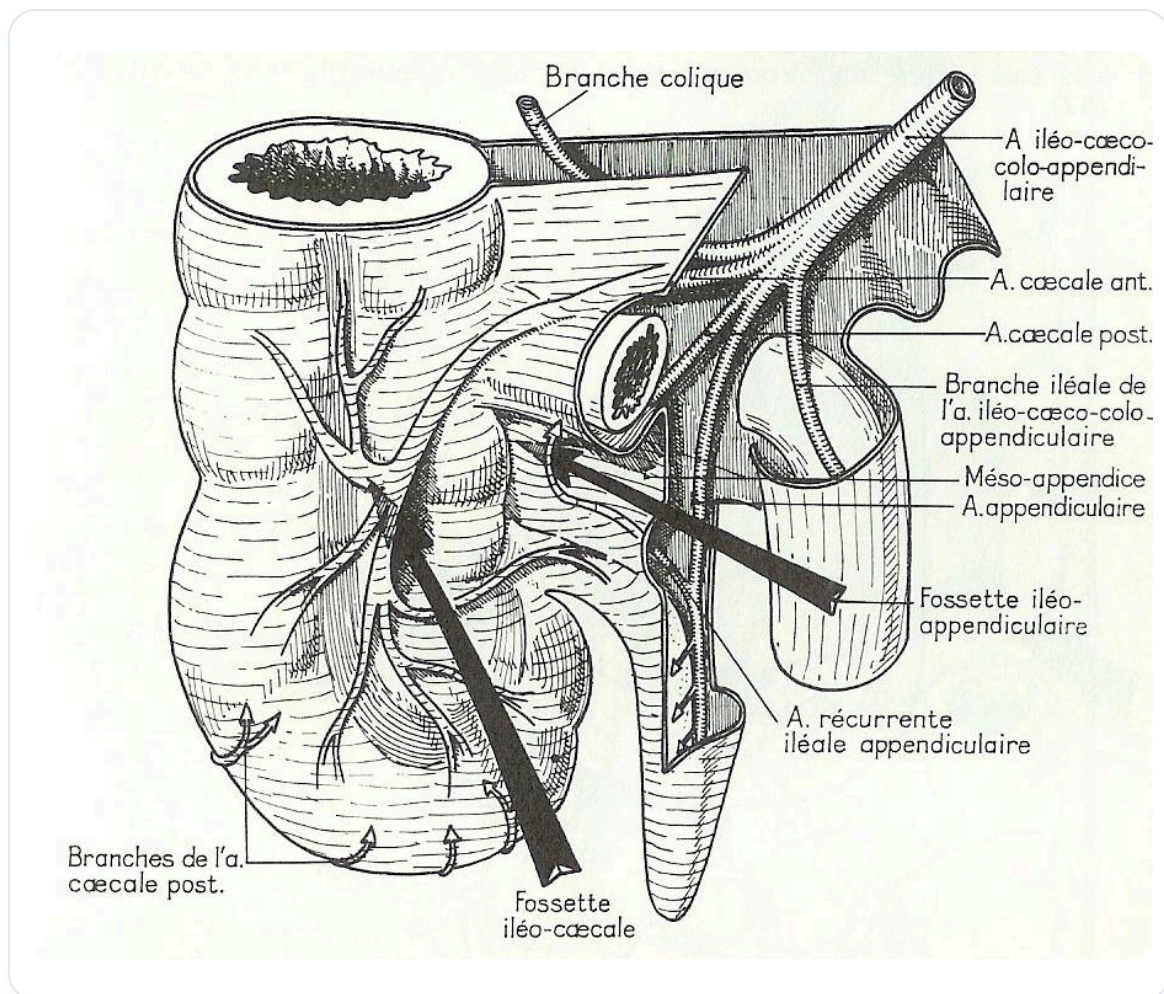


FIG. — Vascolarizzazione appendice cieco